

일부 골반 통증은 방광이나 생식기관이 아니라 골반의 근육, 관절, 신경, 결합조직에서 비롯됩니다 — 흔히 긴장되어 이완되지 않는 과활성 골반저근이 원인입니다. 이는 실제로 존재하는 흔한 증상이며, 검사 결과가 정상이더라도 치료가 가능합니다.

이 질환에 대하여

골반저근(골반저 근육)은 몸의 다른 근육처럼 긴장되거나 경련을 일으킬 수 있습니다. 주요 증상:

- 골반, 회음부, 허리 아래, 엉덩이의 쑤심·압박감·타는 느낌
- **앉을 때**, 성관계 시(성교통), tampon 사용 시, 또는 배변 시 통증
- 방광 자체가 아닌 긴장된 근육으로 인한 **절박뇨 또는 빈뇨**

원인

흔히 여러 요인이 복합적으로 작용합니다: 근육 긴장이나 경련, 과거 손상·수술·출산, 자세와 생활 습관, 스트레스(무의식적 근육 수축 유발), 그리고 때로는 골반 신경 자극. 대개 약한 골반저가 아닌 “짧고 긴장된” 골반저가 문제이므로, 과도한 케겔 운동은 오히려 증상을 악화시킬 수 있습니다.

용어 설명

골반저

골반 장기를 지지하는 근육 구조.

과활성/긴장 골반저

완전히 이완되지 않고 수축 상태를 유지하는 근육.

성교통(Dyspareunia)

성관계 시 발생하는 통증.

통증유발점

다른 부위로 통증을 유발할 수 있는 근육 내 압통점.

골반저 물리치료

이 근육을 이완하고 재훈련하는 물리치료.

이완 훈련(Down-training)

긴장된 골반저를 강화가 아닌 이완시키는 훈련.

음부신경(Pudendal nerve)

자극 시 통증을 유발할 수 있는 골반 신경.

검사는 정상인데 왜 아픈가요? 이 통증은 검사에서 보이는 감염이나 종양이 아닌 근육과 신경에서 비롯됩니다. 검사 결과가 정상이라는 것은 좋은 소식입니다 — 위험한 질환보다 치료 가능한 근육 문제임을 시사합니다. 영상에 나타나지 않는 통증도 엄연히 실재합니다.

진단 방법

- 통증의 위치·시기·악화 요인에 대한 병력 청취
- 골반저근의 압통과 긴장도를 **부드럽게 확인**하는 신체 검사
- 간단한 검사로 감염 등 다른 원인 배제

치료 방법 (단계별)

- 1 골반저 물리치료가 핵심 — 도수 이완, 스트레칭, “이완 훈련”.
- 2 자기 관리 — 온열 요법, 가벼운 운동, 이완·호흡법, 자세 교정, 변비 해소 및 방광 자극 요인 줄이기.
- 3 약물 또는 주사 — 신경통 약물 또는 통증유발점 주사.
- 4 스트레스·수면 관리 (근육 긴장에 큰 영향을 미침).

생활 관리

- 하루 중 턱·엉덩이·골반저의 **긴장**을 알아차리고 의식적으로 이완하세요.
- 온열 요법과 가벼운 스트레칭을 활용하고, 딱딱한 자리에 오래 앉는 것을 피하세요.
- 치료 효과는 수주에 걸쳐 서서히 나타납니다 — 꾸준함이 중요합니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 새로 생긴 **심한** 골반 통증 또는 발열
- 새로운 배변·배뇨 변화, 또는 다리의 무감각·근력 저하
- 낙상·외상 후 통증, 또는 혈뇨·혈변

기억할 세 가지

1. 골반 통증은 흔히 긴장된 과활성 골반근과 신경에서 비롯되며, 검사가 정상이어도 실재하고 치료 가능합니다.
2. 골반저 물리치료(강화가 아닌 이완)가 주된 치료이며, 자기 관리·약물·스트레스 관리를 병행합니다.
3. 호전은 서서히 나타납니다. 새로운 심한 통증, 발열, 다리 무감각·근력 저하, 또는 배변·배뇨 변화가 생기면 즉시 진료를 받으세요.